

Schematy w NPD

Trzy schematy Younga: GRANDIOZJA + NIEWYSTARCZAJĄCA SAMOKONTROLA (zewnętrzna fasada) + UKRYTA DEFEKTYWNOŚĆ (rdzeń). Pierwsze dwa to obrony, trzeci to rana. Bamelis 2014: remisja ~70% po 50 sesjach.

CZAS: 15 min Wersja edukacyjna **ŹRÓDŁO:** Young (2003); Bamelis (2014); Behary (2013)

JAK UŻYWAĆ

1 · Poznasz trzy kluczowe schematy Younga w NPD (sekcja 01) — dwie obrony i jeden rdzeń. **2** · Zrozumiesz cztery *tryby schematowe* (sekcja 02): Samouwielbiciel, Samotne Dziecko, Odcinający się Obrońca, Wymagający Rodzic. **3** · Sprawdzisz, którzy schematycznie reagują u Ciebie w trudnych sytuacjach (sekcja 03). **4** · Zobaczysz drogę terapii schematów — warstwa po warstwie, nie frontalnie (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Young (2003) opisał NPD jako konfigurację **trzech schematów**: grandiozity / uprawnienia i niewystarczającej samokontroli jako *zewnętrznej fasady* oraz defektywności / wstydu jako *rdzenia*. Bamelis i wsp. (2014, wielośrodkowe randomizowane badanie kontrolowane) wykazali, że terapia schematów (ang. *schema therapy*) dla pacjentów z zaburzeniami osobowości klastra B/C osiąga remisję u **około 70% pacjentów po 50 sesjach** — istotnie więcej niż terapia zorientowana na klaryfikację lub leczenie standardowe (ang. *treatment as usual*). W modelu Younga schematy nie są „myślami” — są *głębokimi przekonaniem* o sobie i świecie, ukształtowanymi w dzieciństwie, automatycznie aktywującymi się w trudnych sytuacjach. NPD to *kompensacja* wczesnych nieadaptacyjnych schematów: dziecko z deprywacją emocjonalną dorastający w przekonaniu „nikt mnie nie kocha” buduje obronę „nie potrzebuję nikogo”; dziecko z poczuciem defektywności („jestem wadliwy”) tworzy fasadę „jestem najlepszy”. Te obrony są *kosztowne*: w dorosłym życiu blokują bliskość, uniemożliwiają autentyczność i wymagają nieustannego dopływu admirowania. Praca terapeutyczna: **warstwa po warstwie**, z elementem *limited reparenting* (Young) — terapeuta świadomie pełni funkcję ciepłego, walidującego rodzica. Bezpośrednia konfrontacja grandiozji aktywuje wstyd i jeszcze grubsza fasadę — pacjent odchodzi.

01 Trzy kluczowe schematy w NPD

1 · GRANDIOZJA / UPRAWNIENIE

obrona — fasada

„Jestem wyjątkowy/-a, mi się *należy*.” Przekonanie o przewadze nad innymi, ich zasady mnie nie obowiązują. Roszczeniowość. *Funkcja*: chroni przed wstydem rdzenia.

2 · NIEWYSTARCZAJĄCA SAMOKONTROLA

obrona — impulsywność

„Nie muszę się powstrzymywać, frustracja jest nie do zniesienia.” Impulsywne decyzje, słaba tolerancja dyskomfortu. *Funkcja*: unikanie konfrontacji z rdzeniem przez działanie.

3 · DEFEKTYWNOŚĆ / WSTYD

RDZEŃ — rana

„Jestem wadliwy/-a, brzydki/-a, niewarty/-a miłości.” Najgłębsza warstwa, której pacjent *nie chce* dotknąć. Cała grandiozja jest po to, by nigdy się z tym nie spotkać.

Często dodatkowo aktywne: **depriwacja emocjonalna** („nikt nie zaspokoi moich potrzeb”) → kompensacja: „*nie potrzebuję nikogo*”; oraz **nieufność / nadużycie** („inni mnie skrzywdzą”) → kompensacja: „*zaatakuję pierwszy/-a*”.

02 ◎ Cztery tryby schematowe — kim staję się w trudnej sytuacji

SAMOUWIELBICIEL

ang. *Self-Aggrandizer* — fasada

„Jestem lepszy/-a od wszystkich tutaj.” Aktywuje się w kontakcie z autorytetami, wymagającymi sytuacjami, krytyką. *Chroni przed bólem.*

SAMOTNE DZIECKO

ang. *Lonely Child* — rdzeń

Ukryty pod fasadą. Wstyd, pustka, poczucie defektywności. Aktywuje się w nocy, samotności, po porażce. *To, do czego trzeba dotrzeć.*

ODCINAJĄCY SIĘ OBROŃCA

ang. *Detached Protector* — ucieczka

Intelektualizacja, dystansowanie się, „nie czuję nic”. Tryb obronny, gdy fasada pęka. Ucieka w pracę, alkohol, ekrany.

WYMAGAJĄCY RODZIC

ang. *Demanding Parent* — wewnętrzny krytyk

„Musisz być PERFEKCYJNY/-A, bez błędów.” Aktywuje się po każdej drobnej porażce. *Cel terapii: osłabienie tego głosu.*

03 ✎ Autorefleksja — który tryb aktywuje się u mnie?

Pomyśl o ostatniej sytuacji, w której poczułeś/-aś się *skrytykowany/-a, odrzucony/-a lub niezauważony/-a*. Wypełnij wszystkie cztery pola, nawet jeśli reakcja była tylko wewnętrzna.

SYTUACJA

— co się stało, gdzie, z kim

CO POCZUŁEMI-AM?

— pierwsza reakcja, w ciele i emocjonalna

KTÓRY TRYB SIĘ WŁĄCZYŁ?

— samouwielbiciel, samotne dziecko, odcinający, wymagający

CZEGO TAK NAPRAWDĘ POTRZEBOWAŁEMI-AM?

— pod fasadą, w głębi

04 💡 Droga terapii — warstwa po warstwie

ETAP 1 · ALIANS

3–6 mies. Bez konfrontacji. Terapeuta jako *limited reparenting* — ciepły, walidujący „rodzic”.

ETAP 2 · SAMOKONTROLA

6–12 mies. Praca z niewystarczającą samokontrolą — impulsywność, roszczenia, dyskomfort odraczania.

ETAP 3 · RDZEŃ

1–3 lata. Dotarcie do Samotnego Dziecka. *Imagery rescripting* (Arntz 1999). Praca ze wstydem.

ETAP 4 · INTEGRACJA

Ciągła. Wzmocnienie trybu *Zdrowy Dorosły*. Autentyczne relacje. Profilaktyka nawrotów.

Klucz: bezpośrednia konfrontacja grandiozji **nie** działa — wzmacnia obronę pacjenta, bo aktywuje wstyd, który zostaje natychmiast przykryty kolejną fasadą. Pacjent dewaluuje terapeutę i odpada. Skuteczne podejście to *warstwa po warstwie* (Behary 2008): najpierw **alians** (3–6 mies., bez konfrontacji, *limited reparenting*), potem schemat **niewystarczającej samokontroli**, dopiero później **ukryta defektywność**. *Imagery rescripting* wczesnych scen wstydu (Arntz 1999) sięga rdzenia bez aktywowania obrony grandiozycznej. Optymalny czas: 50–80 sesji, 1–3 lata (Young i wsp. 2003). Bamelis 2014: remisja około 70% — to *najlepszy* wynik dostępny dla NPD.